

Bijlage bij de verordening van 15 december 2025 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Bijlage 55

KANKERREGISTRATIEFORMULIER VOOR EEN NIEUWE DIAGNOSE

Patiënt: Geboortedatum:
 Nationaal nr./Ziekenfondsnr.: Geslacht:

1. INCIDENTIEDATUM (DD-MM-YYYY)¹
2. BASIS VOOR DIAGNOSE²
3. WHO-SCORE BIJ DIAGNOSE³ (Incidentiedatum)
4. PRIMAIRE TUMORLOKALISATIE
5. LATERALITEIT⁴:
6. HISTOLOGISCHE DIAGNOSE EN GEDRAG:/.....
7. DIFFERENTIATIEGRAAD⁵
8. TNM CLASSIFICATIE (meest recente editie van de UICC TNM classificatie)

Klinische TNM (cTNM)	cT ...	cN ...	cM ...
Pathologische TNM (pTNM)	pT ...	pN ...	pM ...
Pathologische TNM na neoadjuvante therapie (ypTNM)	ypT ...	ypN...	ypM...

9. ANDERE CLASSIFICATIE⁶: Stadium:

10. DIAGNOSE EN PRIMAIRE BEHANDELINGEN

A- Maakt de kankerbehandeling deel uit van een klinische studie? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Onbekend

Indien ja, EudraCT nummer

B- Chronologie (chronologisch invullen vanaf datum diagnose en eerste behandeling)

Diagnose ⁷ / behandelingscode ⁸	Campus vestigingsnr.	Startdatum	Einddatum indien bekend	Commentaar (indien 80)
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

11. VERSLAGEN: voeg verslag(en) toe

- MOC-verslagen⁷

1 Volgens meest recente internationale richtlijnen ENCR (European Network of Cancer Registries) en IACR (International Association of Cancer Registries)

2 **Basis voor diagnose:** 2 = histologie primaire tumor, 3 = histologie metastase, 4 = cytologie/hematologie, 5 = technisch onderzoek (bv. RX, endoscopie,...),

6 = klinisch, 7 = tumormarker (bv. PSA, hCG, AFP, Ig,...), 8 = Cytogenetische en/of moleculaire testen, 9 = onbekend

3 **WHO-score bij diagnose** (incidentiedatum): 0 = asymptomatisch, normale activiteit, 1 = symptomatisch, maar ambulant, 2 = symptomatisch, bedlegerig <50% per dag, 3 = symptomatisch, bedlegerig >50% per dag, 4 = aangewezen op volledige verzorging, 100% bedlegerig

4 **Lateraliteit:** 1. Links, 2. Rechts, 3. Onpaar orgaan, #NK Onbekend

5 **Differentiatiegraad:** 1 = goed, 2 = matig, 3 = weinig, 4 = ongediff/anapl, 5 = T-cel, 6 = B-cel, 7 = Nul-cel (niet T/niet B), 8 = Natural Killer (NK)-cel, 9 = onbekend

6 **Andere classificatie:** 1 = Childhood Cancer Stage, 2= FIGO, 3 = Lugano, 4 = Breslow (in mm), 5 = andere

7 Enkel in geval van borsttumoren

8 **Diagnose / Behandelingscode:** 5: diagnose, 10: heilkunde, 11: excisiebipt; 16: HSCT: autoloog, 17: HSCT: allogeen, 20: externe radiotherapie/brachytherapie, 21: IORT, 22: hadrontherapie, 25: concomitant chemoradiotherapie, 26: concomitant radio-immunotherapie, 30: radioisotopen, 35: fototherapie, 36: topicale therapie, 40: chemo-, systemische therapie, 45: targeted therapy (niet 26, 60), 50: hormonale therapie, 60: immunotherapie (niet 26, 66), 66: concomitant chemo-immunotherapie, 70: symptomatisch/palliatief, 75: active surveillance/ watchful waiting, 80: andere behandeling, 90: geen therapie, 95: weigering therapie, 99: onbekend

Bijlage 55 (vervolg 1)

AANVULLENDE KARAKTERISTIEKEN DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR BORSTTUMOREN

1. MENOPAUAZALE STATUS BIJ DIAGNOSE⁹

2. MOLECULAIRE MARKERS:

	Datum	Resultaat tumor 1	Resultaat tumor 2 (indien multifocaal)
Oestrogeen receptor status (ER) ¹⁰			
Progesteron receptor status (PR) ¹⁰			
HER2 IHC-score ¹¹			
HER2 status op basis IHC en ISH ¹²			
BRCA1/2 status ¹³			
CHECK2 status ¹³			
PALB2 ¹³			
ATM ¹³			
PIKCA3 status ¹³			
Ki-67 vóór systemische therapie ¹⁴			
Andere (specificeer)			

3. INDIEN HEELKUNDE:

a. PRIMAIRE TUMOR

Maximale pathologische doormeter invasieve component vóór systemische therapie	 mm
Maximale pathologische doormeter in situ component vóór systemische therapie	 mm
Minimale afstand van de invasieve component tot de snijrand	 mm
Minimale afstand van de in situ component tot snijrand	 mm

b. LYMFEEKLIJEREN

	Aantal onderzocht	Aantal positief	Datum
Sentinelklieren			
Axillaire klieren			
Andere klieren			

Opmerkingen:

- Een kankerregistratieformulier voor een nieuwe diagnose moet steeds binnen een venster van 4 tot 6 maanden na incidentiedatum aan het Kankerregister worden overgemaakt om tijdig een (quasi) volledig overzicht van de diagnose en opeenvolgende gegeven behandelingsmodaliteiten te bekomen.
- Deze continue gegevensflow zal een aanpassing vragen van de jaarlijkse aanlevering die momenteel wordt uitgevoerd.

⁹ Menopauzale status: ja/nee/onduidelijk/niet gekend/niet van toepassing (mannelijke patiënt)

¹⁰ ER/PR: positief/gering positief/negatief

¹¹ HER2 IHC: 0/1+/2+/3+

¹² HER2 status: positief/HER2 low (optie HER2 low niet definitief) /negatief

¹³ BRCA1/2/CHECK2/PALB2/ATM/PIKCA3 niet getest/geen mutatie gedetecteerd/somatische mutatie/kiembaanmutatie

¹⁴ Ki-67: percentage/niet getest

Bijlage 55 (vervolg 2)

REDEN MOC (aankruisen)

- ☐ patiënt met een nieuwe diagnose van kanker
- ☐ voorafgaand aan een oncologische behandeling die afwijkt van de geschreven en door het oncologisch centrum aanvaarde richtlijnen
- ☐ voorafgaand aan een herhaling van een bestralingsreeks van éénzelfde doelgebied binnen de twaalf maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de eerste bestralingsreeks
- ☐ voorafgaand aan een chemotherapeutische behandeling met een geneesmiddel dat in een fase van verzekeringstegemoetkoming door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen werd aangeduid voor monitoring via het multidisciplinair oncologisch consult
- ☐ andere (invullen):

ARTS COORDINATOR (stempel)

Dr: RIZIV-nr:

Instelling:

Datum:

MULTIDISCIPLINAIR ONCOLOGISCH CONSULT

Patiënt :

Nationaal nr./Ziekenfondsnr. :

Aanvrager MOC : RIZIV-id.nr. :

Coördinator MOC : RIZIV-id.nr. :

Deelnemers MOC : 1) RIZIV-id.nr. :

2) RIZIV-id.nr. :

3) RIZIV-id.nr. :

4) RIZIV-id.nr. :

(Extramuros) (1) RIZIV-id.nr. :

Ondergetekende bevestigt als coördinator van het multidisciplinair oncologisch consult dat de bepalingen van de verstrekkingen nr. 350276-350280, 350291-350302 en 350372-350383 werden nageleefd en het aangehechte registratieformulier werd ingevuld.

Instelling:
.....

Datum MOC:
.....

Handtekening coördinator:
.....

Bijlage 55 (vervolg 3)

KANKERREGISTRATIEFORMULIER VOOR HET REGISTREREN VAN FOLLOW-UP

Patiënt:.....

Geboortedatum:.....

Nationaal nr./Ziekenfondsnummer:.....

Geslacht:

I) GEGEVENS OVER DE PRIMAIRE TUMOR

PRIMAIRE TUMORLOKALISATIE (invullen:)

.....

HISTOLOGIE VAN DE PRIMAIRE TUMOR (invullen:)

.....

INCIDENTIEDATUM (DD-MM-YYYY) (het jaar is voldoende indien niet te traceren)

volgorde afnemende prioriteit: 1=eerste hist/cyto bevestiging 2=klin. evaluatie/opname ziekenhuis

ZIEKTEVRIJ INTERVAL? (omcirkelen): JA NEEN

DATUM EERSTE RECIDIEF (indien ziektevrij interval) (DD-MM-YYYY):.....

volgorde afnemende prioriteit: 1=hist/cyto bevestiging 2=opname ziekenhuis/klinische evaluatie

(omcirkelen, meerdere items mogelijk) lokaal regionaal metastasen

II) BEHANDELINGSPLAN IN HET KADER VAN HET HUIDIGE PROBLEEM (intentie tot)

Chronologisch invullen

10: heilkunde

15: beenmergtransplantatie

70: symptomatisch

20: externe radiotherapie/curietherapie

30: isotopen

90: geen therapie

25: concomitant chemoradiotherapie

50: hormonale therapie

95: weigering therapie

40: chemotherapie

60: immunotherapie

80: andere vorm van behandeling: (invullen)

--	--	--	--	--	--

III) REDEN MOC (omcirkelen)

- ☐ behandeling van een patiënt met een recidief
- ☐ behandeling van een patiënt met een progressieve ziekte
- ☐ voorafgaand aan elke oncologische behandeling die afwijkt van de geschreven en door het oncologisch centrum aanvaarde richtlijnen
- ☐ aan een herhaling van een bestralingsreeks van éénzelfde doelgebied binnen de twaalf maanden, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de eerste bestralingsreeks
- ☐ aan elke chemotherapeutische behandeling met een geneesmiddel dat in een eerste fase van verzekeringstegemoetkoming door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen werd aangeduid voor monitoring via het multidisciplinair oncologisch consult
- ☐ andere (invullen):

ARTS COORDINATOR (stempel)

Dr.: RIZIV-nr:

Instelling:

Datum: